THỰC HÀNH TƯ VẤN DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH

ThS. Nguyễn Thùy Linh
Bộ môn Dinh dưỡng - ATTP

MỤC TIÊU

1. Nêu được các phương pháp tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh
2. Trình bày được các kỹ năng tư vấn cho bệnh nhân
3. Thực hiện được phương pháp tư vấn dinh dưỡng trực tiếp

TẠI SAO PHẢI TƯ VẤN

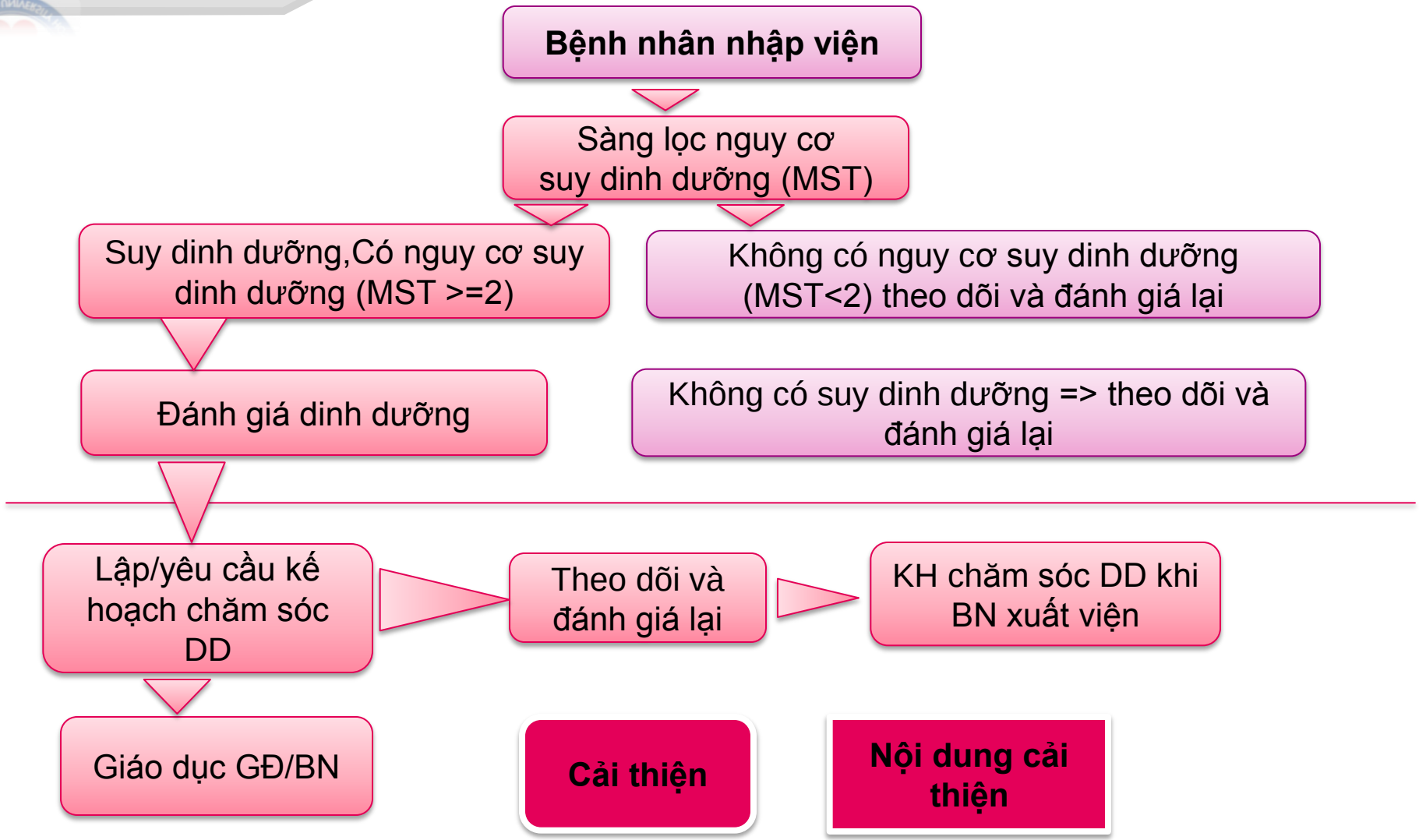
DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH?

VỊ TRÍ CỦA TƯ VẤN TRONG QUY TRÌNH CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN

QUY TRÌNH CHĂM SÓC DINH DƯỠNG

SÀNG LỌC → ĐÁNH GIÁ → CAN THIỆP DINH DƯỠNG

QUY TRÌNH CHĂM SÓC DINH DƯỠNG



CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN

DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH

1. Tư vấn trực tiếp

+ Tư vấn cá nhân

Tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân nằm viện

1. Tư vấn trực tiếp

+ Tư vấn cá nhân

Tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân trước khi ra viện và bệnh nhân ngoại trú

1. Tư vấn trực tiếp

+ Tư vấn theo nhóm nhỏ

2. Tư vấn gián tiếp

+ Tư vấn qua điện thoại

+ Các hình thức tư vấn khác: phát tờ rơi, tài liệu, phát thanh…

3. Thăm gia đình bệnh nhân

1. *Tư vấn trực tiếp:*

- Là hình thức tư vấn hiệu quả nhất
- Đối tượng: bệnh nhân mắc bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng: rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ khác.

- Ưu điểm:

Quan sát trực diện bệnh nhân

Thu nhận được nhiều thông tin từ phía bệnh nhân.

Thông qua từ ngữ, điệu bộ, cử chỉ và ánh mắt cũng làm tăng hiệu quả của tư vấn.

- Hạn chế : Số lượng bệnh nhân ít.

+ ***Tư vấn cá nhân:***

- Đánh giá: tình trạng dinh dưỡng BN, các loại TP bệnh nhân sử dụng và các thói quen về lối sống mà BN lựa chọn.
- Lập kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng dựa vào nhu cầu dinh dưỡng BN cũng như mục tiêu cần đạt được sau khi thực hiện chế độ dinh dưỡng.
- Cuộc tư vấn kéo dài khoảng 30-60 phút, sau đó nên xác định nhu cầu tư vấn và số lần sẽ gặp để tư vấn.
- Tạo cơ hội để khen ngợi và củng cố các thực hành mới nhằm xây dựng lòng tin của BN

+ ***Tư vấn cá nhân:***

* Ưu điểm: Cụ thể, chi tiết cho người được tư vấn, mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh.

* Nhược điểm: không tư vấn cho được nhiều đối tượng 1 lúc, cán bộ tư vấn vất vả hơn, cần tập trung cao độ hơn

+ ***Tư vấn theo nhóm nhỏ:***

- Thường được tổ chức tại bệnh phòng, hội trường khoa dinh dưỡng hoặc căng tin của bệnh viện.
- Mọi người cùng trao đổi, chia sẻ bàn bạc về một chủ đề
- Là một trong những phương pháp thông dụng và có hiệu quả trong truyền thông giáo dục dinh dưỡng.
- Nhóm BN khoảng 8-12 người. Nhóm càng nhỏ thì hiệu quả tư vấn càng lớn
- Tổ chức 1-2 tuần /lần
- Cộng tác viên cần phải chuẩn bị tốt chủ đề, câu hỏi, các tình huống, nên có quyển cẩm nang hướng dẫn dinh dưỡng lâm sàng

+ ***Tư vấn theo nhóm nhỏ:***

* Ưu điểm: một lúc có thể truyền đạt kiến thức đến nhiều người

* Nhược điểm: Kiến thức truyền đạt không cụ thể cho từng BN cho nên áp dụng cho từng người có trường hợp không hiệu quả.

2.2. Thăm gia đình bệnh nhân:

- Nhân viên y tế hiểu rõ hơn hoàn cảnh thực tế chăm sóc dinh dưỡng của gia đình
- BN mới ra viện, BN ăn sonde tại nhà, BN truyền tĩnh mạch... GĐ có trẻ bị SDD, gia đình BN có hoàn cảnh đặc biệt (nghèo, có ít người chăm sóc)...
- Nên quan sát kĩ lưỡng nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt, thói quen ăn uống.
- Lắng nghe và xác định các vấn đề khó khăn trong chăm sóc nuôi dưỡng bệnh nhân.
- Hướng dẫn thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho BN

2.3. Tư vấn gián tiếp

Phát tài liệu, tờ rơi, tư vấn qua điện thoại hoặc phát thanh trên loa, đài...

*** Tư vấn qua điện thoại:**

- BN có thể tiếp cận cán bộ tư vấn bất kì lúc nào mà họ muốn
- BN nói chuyện rất cởi mở vì họ không biết cán bộ tư vấn.

-Nhược điểm: Cán bộ tư vấn chỉ nghe được giọng nói của bệnh nhân mà không quan sát được họ. (Nhất là vùng nghèo, xa xôi).

*** Các hình thức tư vấn khác như phát tờ rơi, tài liệu, phát thanh...** đáp ứng được số đông bệnh nhân nhưng không có phản hồi do vậy hiệu quả thấp.

CÁC BƯỚC TƯ VẤN

DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ

1. *Tạo mối quan hệ*
2. *Đánh giá thực hành ăn uống của người bệnh và các yếu tố nguy cơ*
3. *Cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến chăm sóc dinh dưỡng của bệnh nhân*

4. Giúp bệnh nhân lựa chọn giải pháp thích hợp nhất. Xây dựng và thống nhất với bệnh nhân về các mục tiêu thay đổi chế độ ăn của bản thân

5. Giúp người bệnh phát triển kế hoạch hành động và thực hiện những thay đổi thực hành ăn uống hoặc giải quyết các trở ngại

6. Theo dõi và hỗ trợ thường xuyên để duy trì những thay đổi về chế độ ăn

CÁC KỸ NĂNG TƯ VẤN

DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ

1. Kỹ năng làm quen và phân tích bệnh nhân

2. Kỹ năng lắng nghe

3. Kỹ năng quan sát

4. Kỹ năng cung cấp thông tin

5. Kỹ năng xây dựng niềm tin

1. Kỹ năng làm quen và phân tích bệnh nhân

- Kỹ năng cần thiết đầu tiên cho công việc tư vấn bệnh nhân.
- Cán bộ tư vấn cần gặp gỡ, liên lạc và nói chuyện với BN
- Thông tin: tuổi, giới, trình độ giáo dục, kiến thức, quan điểm và hành vi ăn uống liên quan đến bệnh.
- Bằng những câu hỏi cho BN

2. Kỹ năng lắng nghe

- Kỹ năng lắng nghe giúp cán bộ tư vấn hiểu rõ hơn BN
- Thông qua: lắng nghe, thông cảm và quan sát BN.

Làm thế nào để lắng nghe tốt ?:

- Thể hiện sự thông cảm, tôn trọng và quan tâm đến những điều bệnh nhân đang nói.
- Tránh biểu thị sự khó chịu, buồn bực và mệt mỏi. (nhất là người già, BN nặng)

3. Kỹ năng quan sát

- Thường sử dụng khi đến thăm gia đình bệnh nhân hoặc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

- Nên nhìn toàn cảnh gia đình, đồ dùng, môi trường xung quanh, quan sát cách ứng xử của người nhà bệnh nhân và ngược lại.

4. Kỹ năng cung cấp thông tin

- Chỉ cung cấp thông tin hoặc nói cho gia đình bệnh nhân những gì họ nên làm.
- Nên lắng nghe họ và sau đó trao đổi các thực hành mà họ có thể sử dụng trong hoàn cảnh cụ thể của họ.
- Các thông tin: các kỹ năng chế biến TP, cách lựa chọn TP, các phương pháp mới để nuôi dưỡng trẻ SDD, những ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng một loại TP nào đó.
- Nên sử dụng mô hình, tranh lật để BN dễ hiểu hơn.
- Cung cấp thông tin nên từ từ, ít một, mỗi lần chỉ nên giới hạn 1-2 thông tin để tránh quá tải cho bệnh nhân.

5. Kỹ năng xây dựng niềm tin

- Nghe và ghi nhận những điều mà người bệnh nghĩ hoặc cảm thấy với thái độ chia sẻ và thông cảm.
- Phát hiện và khen ngợi những hành vi tốt sẵn có của người bệnh.
- Hướng dẫn cụ thể nơi mua thực phẩm, giá cả, chủng loại, hãng sản xuất, số lượng và cách chế biến món ăn.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài 1: Anh/chị hãy tư vấn dinh dưỡng cho 1 bệnh nhân nam 50 tuổi, cao 165 cm, nặng 68kg, bị tăng huyết áp. Dưới đây là khẩu phần ăn trong 24 giờ của bệnh nhân:

Gạo tẻ máy	430	
Sữa bò tươi	200	
Dầu ăn	20	
Đường	40	
Cà chua	100	
Rau cải thìa	300	
Thịt bò thăn	80	
Cần tây	50	
Susu	100	

Bài 1: Nhóm 2 cùng tổ:

Thực hành tư vấn trực tiếp theo hình thức Tư vấn nhóm cho 1 nhóm 10- 15 bệnh nhân trên 50 tuổi bị tăng huyết áp đang điều trị tại cộng đồng

Bài 2: Anh/chị hãy tư vấn dinh dưỡng cho 1 bệnh nhân nữ 54 tuổi, cao 155 cm, nặng 50kg, bị đái tháo đường đang điều trị tại cộng đồng. Dưới đây là khẩu phần ăn trong 24 giờ của bệnh nhân:

Gạo tẻ	200g
Đậu phụ	60g
cà chua	50g
Dầu thực vật	20g
Cải bắp	100g
măng	100g
thịt lợn sấn	40g
thịt gà loại 1	50g
lạc	25g
vừng	25g
Chuối tiêu	75g

Bài 2: Nhóm 2 cùng tổ:

Thực hành tư vấn trực tiếp theo hình thức Tư vấn nhóm cho 1 nhóm 10- 15 bệnh nhân trên 50 tuổi đang điều trị ĐTĐ tại cộng đồng

Bài 3: Anh/chị hãy tư vấn dinh dưỡng cho 1 bệnh nhân nam 54 tuổi, cao 166 cm, nặng 50kg, bị suy thận mạn tính đang điều trị tại cộng đồng. Dưới đây là khẩu phần ăn trong 24 giờ của bệnh nhân:

Bánh phở 150g	
Thịt gà xé 30g	
Nước xương	
Rau thơm, hành, ớt…	
Cơm	**Cơm**
Cơm gạo tẻ 120g	Cơm gạo tẻ 120g
Thịt nạc mông rim 20g	Cá file rán 120g
Mọc xốt 20g	Cải ngọt luộc 150g
Khoai tây xào 150g	Canh ngót 20g
Canh ngót 20g	

Bài 3: Nhóm 2 cùng tổ:

Thực hành tư vấn trực tiếp theo hình thức Tư vấn nhóm cho 1 nhóm 10- 15 bệnh nhân trên 50 tuổi đang điều trị suy thận tại cộng đồng

Bài 4: Anh/chị hãy tư vấn dinh dưỡng cho 1 bệnh nhân nam 60 tuổi, cao 166 cm, nặng 60 kg, bị Gout đang điều trị tại cộng đồng. Dưới đây là khẩu phần ăn trong 24 giờ của bệnh nhân:

Phở thịt gà	Cơm
Bánh phở 150g	Cơm gạo tẻ 120g
Thịt gà 30g	Thịt gà rang 100g
Nước xương	Lạc rang 20g
Rau thơm, hành, ớt..	Bắp cải luộc 200g
Cơm	Canh bí 50g
Cơm gạo tẻ 120g	
Đậu 1 bìa nhồi 20g thịt	
Lạc rang 30g	
Muống luộc 200g	
Canh ngót 30g	

Bài 4: Nhóm 2 cùng tổ:

Thực hành tư vấn trực tiếp theo hình thức Tư vấn nhóm cho 1 nhóm 10- 15 bệnh nhân bị loét Dạ dày – Tá tràng đang điều trị tại cộng đồng

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
06/05/2012